

13 - 03- Les Dyspepsies - Pr. Samlani

Bonjour, aujourd'hui nous verrons les dyspepsies. Le terme dyspepsie signifie étymologiquement une difficulté à digérer. C'est un motif de consultation extrêmement fréquent et il est important de distinguer deux catégories.

D'abord la dyspepsie organique, due à un problème organique et qui représente un tiers des cas. Ensuite les dyspepsies fonctionnelles qui sont plus fréquentes, deux tiers des cas. Les causes organiques sont dominées par les lésions du tractus digestif et la démarche diagnostique a pour but essentiellement d'éliminer une cause organique.

Donc la dyspepsie fonctionnelle reste un diagnostic d'exclusion. Une dyspepsie est définie comme étant un ensemble de symptômes. C'est une douleur ou un inconfort chronique ou récidivant de la région épigastrique provenant du tractus ou du tube digestif supérieur.

Donc le patient peut vous la décrire comme une sensation d'inconfort qui est chronique et qui est récidivante. Ça peut être également une douleur épigastrique à type de brûlure ou de crampe comme le patient peut vous la décrire comme étant un ballonnement de l'épigastre. Parfois ils peuvent vous parler d'une digestion qui est lente, qui le dérange parce que quand il mange il se sent en inconfort et il vous parle de cette difficulté de digestion.

Ou bien une satiété précoce qui va empêcher notre patient d'avoir des repas corrects ou de quantité suffisante. On définit le syndrome dyspeptique selon les critères de Rome. On en parle quand un ou plusieurs des quatre symptômes sont présents.

Le premier c'est la répression postprandiale. Ce sont généralement des troubles suivants après les repas et le patient a une sensation de plénitude et de pression. On l'appelle également syndrome de détresse postprandiale.

Le second critère c'est la satiété précoce. C'est-à-dire que le patient a rapidement une sensation de satiété. La faim n'existe plus, ce qui le rend incapable de finir un repas de taille normale.

Douleur épigastrique à type de crampes ou bien même des brûlures. Donc un ou plusieurs de ces quatre symptômes rentrent dans la définition d'un syndrome dyspeptique. Les douleurs épigastriques peuvent être intermittentes, d'intensité plus ou moins modérée, au minimum une fois par semaine.

C'est le caractère chronique la dyspepsie. Il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas généralisée ou bien irritante dans d'autres régions abdominales ou même thoraciques. Pourquoi ? Parce qu'il faut éliminer les autres diagnostics différenciés d'une dyspepsie.

Il faut bien sûr éliminer les pathologies cardiaques. La dyspepsie est une maladie chronique. C'est un problème de santé publique.

Environ 5% des consultations de médecine générale ambulatoire peuvent être reliées à des dyspepsies. La prévalence moyenne est de l'ordre de 25%. Elle est plus élevée chez la femme.

Elle diminue un petit peu avec l'âge. Sur cette diapositive, vous avez un rappel anatomique de l'estomac. Vous voyez l'ucardia.

Vous voyez bien sûr la partie verticale de l'estomac qu'on appelle communément le fundus. Et vous voyez l'entre et bien sûr le pivore. Et là, vous avez un rappel de l'histologie de l'estomac.

Vous vous rappelez que ceci, c'est une présentation schématique des glandes, du fundus et du corps. Et vous vous rappelez qu'on a différentes cellules et qui vont s'imaginer avec présence de glandes et que chaque cellule a une particularité, une sécrétion différente. Vous voyez ici des cellules à mucus.

Vous voyez des cellules pariétales qui existent au niveau de la partie verticale de l'estomac et qui vont sécréter de l'HCL du facteur intrinsèque. Vous voyez des cellules principales qui vont sécréter le pepsinogène qui va se transformer en pepsine et qui a un rôle dans la digestion. Et l'estomac se caractérise par deux fonctions principales.

Une activité chimique ou sécrétion gastrique. C'est cette sécrétion gastrique qui a un rôle important dans la digestion. Et vous avez bien sûr une activité mécanique ou motricité qui va permettre la vidange et qui sera synchrone au phénomène de digestion.

La sécrétion gastrique est composée de plusieurs éléments. Il y a la sécrétion gastrique acide, faite d'HCL et des gastrines. Le facteur intrinsèque, les bicarbonates.

Vous vous rappelez ce schéma où il y a les trois phases de la fonction chimique de l'estomac. Où il y a la régulation. Et vous voyez que la sécrétion gastrique obéit à une régulation à différents niveaux.

Tout d'abord, il y a la phase céphalique où la vue, le goût, l'odeur va transmettre un message aux bulbes où il y aura une potentialisation de la sécrétion gastrique. On a bien sûr la phase gastrique et la distension de l'estomac qui va participer à cette sécrétion. Et en dernier lieu, une phase intestinale.

L'activité mécanique de l'estomac, c'est ce qu'on appelle la motricité gastrique. L'estomac a trois parties. Il y a l'estomac proximal où la partie verticale qui a un rôle de réservoir et qui va se distendre et réaliser ce qu'on appelle une relaxation adaptative quand les aliments arrivent.

Et il y a l'estomac distal qui va réaliser d'autres mouvements de broyage, de brassage, de mélange, de propulsion et qui va donc envoyer tout ça vers le pylore et vers l'intestin. Et on voit ici la partie verticale de l'estomac qui a essentiellement un rôle de réservoir et la partie horizontale qui est dotée de mouvements, de brassage, de mélange et de propulsion avec le

pylore qui est doté d'un sphincter et qui va déverser au niveau du duodenum le contenu de l'estomac. Ce sont ces mouvements-là, vous avez vu ça en physiologie, de brassage et de mélange avant la déviation au niveau du duodenum.

Alors pour la physiopathologie proprement dite de la dyspepsie, les mécanismes appliqués ne sont pas clairement élucidés. On sait par contre qu'une conjonction ou une association de plusieurs éléments peut être responsable d'un syndrome dyspeptique. Alors quels sont ces différents éléments ? En A, il peut y avoir un retard de la vidange gastrique.

Les anomalies du péristaltisme gastrique, un retard de la vidange des solides ou des liquides va faire que l'estomac va se remplir et il y aura cette sensation de plénitude post-prandiale, de répression. Et comme il y aura cette sensation de plénitude, ça va occasionner des nausées, ça va occasionner aussi peut-être même un reflux, des vomissements. Et c'est ce qu'on appelle la dyspepsie motrice.

Pourquoi ? Parce que la physiopathologie est fondée sur un trouble de péristaltisme. Deuxièmement, des anomalies de la compliance gastrique. Ça veut dire quoi ? La compliance, c'est cette capacité d'adaptation de l'estomac.

Une hypomotilité entraine, ça veut dire que l'entre ne bouge pas assez. Des troubles du rythme de la contraction gastrique, une altération de la motricité du dénon jejunal ou bien un estomac qui est moins bien compliant, tout ça va faire qu'il y ait cette sensation de plénitude et de retard à la digestion que le patient va vous rapporter. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est un désordre dans les voies de régulation nerveuse et il y aura une sensation de plénitude et une sensation de satiété précoce rapidement.

Dès que le patient mange, il n'y a pas assez de compliance, il n'y a pas assez de phénomène moteur d'adaptation et donc il n'aura pas faim et il va avoir tendance à limiter ses repas. En C, ou troisième mécanisme, on peut évoquer aussi comme mécanisme physiopathologique une hypersensibilité à la distanciation gastrique. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de perception douloureux à la distanciation qui est anormalement bas.

Dès qu'il y a une distanciation, le patient a mal. Et il aura cette sensation de crampe au niveau du creux épigastrique et c'est ce qu'on appelle une dyspepsie pseudomycéreuse. Donc vous avez vu qu'on a vu en 1 une dyspepsie motrice et que maintenant on voit une autre dénomination.

C'est une dyspepsie qui se manifeste par des crampes, c'est une dyspepsie pseudomycéreuse. Un autre élément peut rentrer en jeu, c'est l'infection *helicobacter pylori*. Alors le rôle d'*helicobacter pylori* dans la dyspepsie n'est pas vraiment élucidé.

Mais on comprend, et on le verra dans les chapitres des gastrites, que quand il y a une inflammation chronique, il peut y avoir une diminution du seuil de la douleur. Et il peut y avoir bien sûr une sensibilité à la distanciation et ça peut occasionner une dyspepsie. Enfin, on évoque

des facteurs psychologiques.

On dit que chez certains patients qui sont angoissés, les troubles dyspeptiques sont plus fréquents. Alors, après cette physiopathologie, quelle sera la démarche diagnostique ? On a vu dans l'introduction que ce qui était le plus important, c'est d'éliminer ce qui était organique. Donc le but dans cette démarche diagnostique, c'est de faire un diagnostic positif, de définir les circonstances de découverte et les symptômes qui caractérisent la dyspepsie.

C'est-à-dire, quoi faire le diagnostic positif ? C'est-à-dire, voir s'il y a les critères dont on a parlé, les critères d'Europe. Définir les circonstances de découverte et les symptômes caractérisant la dyspepsie. Voir si elle s'apparente plus à une dyspepsie motrice ou bien pseudo-ulcéreuse.

Et bien sûr, identifier les signes d'alarme et les signes en faveur d'une lésion organique. Les circonstances de découverte sont variables. En général, le patient se plaint de plénitude postprandiale gênante après des repas qui sont normaux.

Ça veut dire qu'il n'a pas trop mangé et pourtant il se sent plaint. Et plusieurs fois par semaine, c'est le caractère chronique. Le patient peut rapporter une satiété précoce, une incapacité à finir un repas de taille normale, des douleurs épigastriques à type de brûlure, parfois un ballonnement, parfois des nausées, des éructations.

Et on a dit qu'il fallait faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'irradiation thoracique ou d'irradiation abdominale. Dans ce cas-là, comme on a vu en sémiologie, l'interrogatoire très important va renseigner sur l'âge, sur l'ancienneté des symptômes, sur le rapport avec un repas particulier, voir si ça a été déclenché par un repas particulier, s'il n'y a pas un facteur déclenchant, sur le caractère nocturne-nocturne, sur le retentissement sur ce patient, l'efficacité des traitements pris. Et il est toujours important, quand on fait l'interrogatoire bien sûr, de rechercher les antécédents médicaux, toutes les prises médicamenteuses récentes, les antécédents chirurgicaux, personnels et familiaux.

Après cela, bien sûr, on fait toujours un examen clinique et dans le cas de la dyspepsie, il est souvent pauvre. Parfois on peut trouver une petite sensibilité épigastrique chez certains patients. Sur cette diapositive, vous voyez les signes d'alarme.

C'est quoi les signes d'alarme ? Ce sont les choses, ce sont les signes qui nous orientent vers quelque chose d'organique et qui nous imposent de sonner l'alarme et d'explorer le patient un petit peu plus loin. Et généralement, ces signes d'alarme, on les a déjà à l'interrogatoire. C'est l'âge au-delà de 45 ans, c'est l'hémorragie digestive, l'antécédent de saignement extériorisé, c'est l'amaigrissement du patient récent supérieur à 10%, une anorexie, des vomissements persistants, une anémie, une dysphagie progressive ou une odinophagie, c'est-à-dire une douleur à la déglutition, des antécédents personnels ou familiaux de cancer digestif, des antécédents de chirurgie gastrique ou un antécédent du cervix lisse.

L'examen clinique est souvent pauvre. Cependant, on le fait toujours et on le complète, un examen abdominal avec un toucher rectal et un examen général. Et on recherche, bien sûr, un nictère, on recherche des adénopathies.

Quand on examine l'abdomen, on recherche une masse abdominale, on fait un toucher rectal et on recherche un saignement. Et la présence d'un signal d'alarme, d'un signe d'alarme ou bien d'un de ces signes impose bien sûr des examens complémentaires. Alors quels sont les examens complémentaires qu'on va réaliser ? Pour la biologie, il faut savoir d'abord ce qu'on cherche.

Quand on pense à un diabète qui peut occasionner une gastroparesie, et la gastroparesie est un trouble fonctionnel chronique qui est caractérisé par un ralentissement à la vidange gastrique en dehors de tout obstacle, on fera une glycémie, un jeun ou peut-être même une hémoglobine liquée. Quand on pense à une anémie, on fera un dosage de l'hémoglobine et à rappeler que l'anémie est un signe d'alarme qui imposera des explorations poussées. Quand on pense à un problème de malabsorption d'hyperparathyroïdes, un dosage de la calcémie s'imposera.

On fera un bilan hépatique à la recherche d'une origine hépato-myliopancréatique. Et on fera un bilan inflammatoire qui pourra nous orienter vers une infection digestive, un cancer ou une maladie de système. La fibroscopie ou osogastro-diodénoscopie est l'examen de choix pour explorer le zovage, l'estomac et le diodéname.

Il nous permettra de voir s'il n'y a pas une cause organique et de réaliser des biopsies à la recherche des échobactères pylori. L'échographie abdominale est un examen qui est peu coûteux, qui n'est pas invasif et qui permettra bien sûr de voir le foie, de voir la vessie cubilière, de voir s'il y a éventuellement des adénopathies et d'orienter peut-être vers d'autres examens complémentaires. D'autres examens peuvent s'imposer, notamment une PH météorosophagienne quand on pense à un reflux gastro-osophagien, surtout lorsqu'on a traité et qu'il n'y a pas de réponse thérapeutique.

Et on peut pousser les explorations radiologiques plus loin par un scanner abdominal lorsqu'il existe des épigastralgies orientant vers une pathologie pancréatique. Alors quelles sont les étiologies ? Les étiologies sont devinées dans un tiers des cas par la dyspepsie organique et dans les deux tiers par la dyspepsie fonctionnelle. Tout d'abord, les causes organiques.

Pour les lésions digestives, il s'agit de l'ulcère gastro-diédénale. Et vous verrez en cours de pathologie que l'ulcère est une maladie qui se caractérise par une perte de substance au niveau de la muqueuse, la sous-muqueuse, amputant la musculature, épouvant ce compliqué, démorager de perforation. Ensuite, il y a l'osophagite peptique, qui est une inflammation du vasophage, qui est une complication du reflux gastro-osophagien avec au sang herniatal.

Ensuite, le cancer gastrique osophagien. Ensuite, bien sûr, la gastroparesie, que ce soit dans le

cadre d'un diabète, d'une vagotonie qui est une section des nerfs d'âgles, ou bien dans certaines maladies telles que la sclérodermie. Et enfin, les infiltrations gastriques, que ce soit dans le cadre de maladies telles que la malaise de Crohn, la sarcoïdose ou la mylose.

Il y a également les infections gastriques, virales à cytomégalovirus ou bactériennes. Le bacille de corps, la syphilis. Certaines parasitoses peuvent également occasionner une dyspepsie.

Et il ne faut pas oublier que les pathologies pancréatiques au biliaire, que ce soit le cancer du pancréas, la pancréatite ou les lithiases la voie biliaire principales, peuvent perturber la digestion et l'absorption par défaut, par insuffisance pancréatique ou par insuffisance biliaire. Et avoir également des symptômes qui se rapprochent de la dyspepsie. Pour les autres causes, ce sont les causes médicamenteuses.

Beaucoup de médicaments, certains antibiotiques, des anti-inflammatoires, des inhibiteurs de la pompe à proton peuvent être responsables des dyspepsies. Il y a également les endocrinopathies, telles que les dysthyroïdies ou le diabète par un autre mécanisme tel que la gastroparesie, et les maladies de système. Pour ce qui est des dyspepsies fonctionnelles, ou bien dites idiopathiques chroniques, celles-ci sont retenues comme diagnostic si les symptômes sont présents depuis plus de trois mois consécutifs, avec un début de plus de six mois avant le diagnostic, et à l'absence de toute cause organique à l'endoscopie, de toute cause systémique, métabolique, expliquant les symptômes.

C'est pour ça que ça reste, comme on l'a dit dans l'introduction, un diagnostic d'exclusion. Et l'évolution est chronique, et bien sûr, les symptômes vont persister si on ne les traite pas. Dernier volet, qu'est-ce qu'aura la prise en charge thérapeutique ? Cette prise en charge va reposer sur, un, des règles hygiénothétiques.

Il faut éviter les aliments pouvant exacerber les symptômes. Éviter les aliments qui peuvent ralentir ou affecter la motricité gastrique, l'alcool, le tabac, le café. Fractionner les repas en diminuant leur teneur en graisse.

Le traitement peut reposer sur des traitements pharmacologiques, des antisécrétoires gastriques, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons, des agents prokinétiques qui vont améliorer la motricité gastrique. Et tous ces traitements-là agissent pour traiter ou pour améliorer les symptômes de plénitude postprandiale, les nausées et les vomissements. Quels sont les autres traitements ? Vous avez vu qu'on a parlé dans le chapitre physiopathologie du rôle de l'anxiété qui a été évoqué dans cette pathologie.

La psychothérapie de soutien, les méthodes de relaxation, l'hypnose et les thérapies comportementales, les antidépresseurs ont été éventuellement évoquées comme des moyens thérapeutiques. Quand on parle de traitement, on évoque également les indications. Les indications du traitement vont dépendre de l'existence de signes d'alarme et de l'âge du patient.

Pour les dyspepsies fonctionnelles, en l'absence de signes d'alarme, on peut traiter par traitements empiriques, ce sont des IPP à pleine dose pendant un mois, ou bien des prokinétiques quand il s'agit d'une forme motrice pour améliorer la motricité de l'estomac et sa vidange. C'est ce qu'on appelle la stratégie testée et traitée. Il faut également rechercher *helicobacter pylori* par un moyen quelconque.

Et en l'absence de signes d'alarme, ce traitement peut être suffisant. Une fibroscopie sera réalisée si elle cherche du traitement par IPP et du traitement d'éradication d'*helicobacter pylori*, évidemment quand il n'y a pas de signes d'alarme. Pour ce qui est de dyspepsie organique, quand on a trouvé une cause, il faut traiter symptomatiquement, mais il faut également traiter l'étiologie, c'est-à-dire arrêter la cause de ces dyspepsies.

Quand c'est un médicament, il faut l'arrêter. Quand c'est un problème endocrinologique, diabète, dysthéologie, il faudra bien évidemment l'équilibrer. Quand c'est une maladie de système ou un problème infectieux, inflammatoire, il faudra le traiter.

Et bien sûr, quand il s'agira d'un cancer ou d'une pathologie organique spécifique, il faudra prescrire le traitement médical ou chirurgical adéquat. Donc je finirai en disant que quand on est face à une dyspepsie, il faut d'abord poser les diagnostics de dyspepsie selon les critères de Rome. Les critères de Rome 3 sont les plus récents.

Quand il y a des signes d'alarme, ceux dont on a parlé, il faut d'emblée faire une endoscopie digestive haute. En l'absence de signes d'alarme, il faut penser s'il n'y a pas prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faudra les arrêter.

Quand c'est efficace, c'est tant mieux. Quand c'est pas efficace, on pourra traiter par un traitement, par IPP notamment, ou bien par des prokinétiques en association. Quand c'est efficace, c'est tant mieux.

Si c'est pas efficace, notre stratégie de tester et traiter et tester n'est pas efficace. Et dans ce cas là, il faudra réaliser une endoscopie digestive haute. Et bien évidemment, c'est l'interrogatoire, c'est l'examen clinique qui peuvent nous orienter vers des étiologies spécifiques.

Et dans ce cas là, on fera les bilans biologiques adéquats et on fera les autres explorations adéquates. En conclusion, la dyspepsie est extrêmement fréquente. La majorité des patients n'ont pas de lésion organique et vont présenter une dyspepsie non ulcéreuse ou un reflux gastro-oesophagien.

La fibroscopie est indiquée quand on suspecte une lésion organique ou bien quand on a des signes d'alarme, ou bien chez des patients qui récidivent après un traitement empirique. Le traitement de choix la dyspepsie non investiguée, c'est à dire là, on n'a pas cherché des examens complémentaires. Ce sera les IPPSL avec éradication des glycobactères pyloriques.

